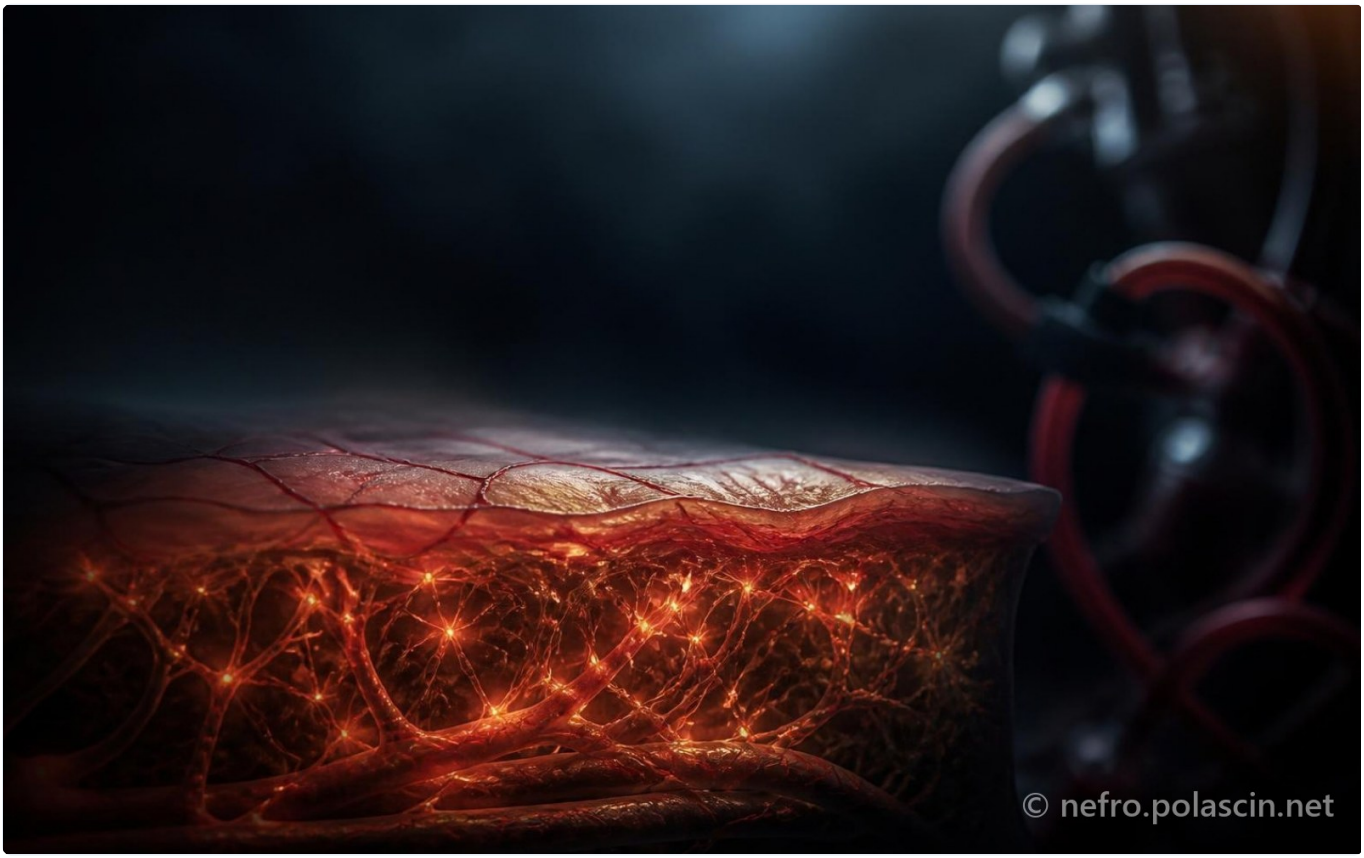
Svrbenie (pruritus) na dialýze: prečo sa udávaná prevalencia líši dvojnásobne a čo pacient sám nepovie

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Pod kožou sa deje veľa, v dokumentácii nič – preto sa udávaná prevalencia líši podľa toho, ako sa pýtame.

Pruritus spojený s chronickou chorobou obličiek patrí k symptómom, ktoré dialyzovaného pacienta obťažujú najviac a v ambulancii sa spomenú najmenej. Nová turecká štúdia s kombinovaným kvantitatívno-kvalitatívnym dizajnom priniesla údaj, ktorý sa rýchlo rozšíril: stredne ťažké až ťažké svrbenie malo **16,3 %** hemodialyzovaných.

To číslo je vecne správne – a zároveň sa nedá použiť ako odpoveď na otázku „koľko našich pacientov svrbí“. Dôvod je poučný a týka sa každého symptómového ukazovateľa, ktorý meriame dotazníkom.

Čo štúdia urobila

Autorky použili sekvenčný vysvetľujúci zmiešaný dizajn: prierezovú kvantitatívnu fázu a na ňu nadväzujúcu kvalitatívnu fázu s reflexívnou tematickou analýzou. Prebehla v troch dialyzačných strediskách pridružených k univerzitnej nemocnici v Ankare od októbra 2025 do januára 2026. Z približne 520 dialyzovaných dospelých sa zúčastnilo **294, teda približne 57 %** (vlastný orientačný prepočet z približného menovateľa); dôvody neúčasti zvyšných pacientov práca neuvádza.

Závažnosť sa merala tureckou verziou päťdimenzionálnej škály svrbenia (5-D), ktorá hodnotí trvanie, intenzitu, vývoj, obmedzenie činností a rozsah postihnutia. Priemerné skóre bolo 8,00 ± 3,21 pri nameranom rozsahu 5,00 až 19,75 a vnútornej konzistencii 0,77.

Kategória podľa 5-D	Skóre	Počet	Podiel
„Bez pruritu“	5–8	193	65,6 %
Mierny	9–11	53	18,0 %

Kategória podľa 5-D	Skóre	Počet	Podiel
Stredne ťažký	12–17	37	12,6 %
Ťažký	18–21	11	3,7 %
Veľmi ťažký	≥ 22	0	0 %

Aspoň mierne svrbenie (5-D ≥ 9) teda malo 101 pacientov (34,4 %) a stredne ťažké až ťažké 48 pacientov (16,3 %). Údaj 34,4 % pritom v abstrakte nie je – kto cituje len abstrakt, nájde tam iba 16,3 %.

Prečo 16,3 % nie je „prevalencia svrbenia pri dialýze“

1. **Kategória „bez pruritu“ neznamená, že pacienta nesvrbí.** Znamená skóre 5 až 8 na škále, ktorej minimum je 5. Pacient, ktorého občas a mierne svrbí, sa do tejto kategórie dostane bez ťažkostí.
2. **Hranica pre „stredne ťažký až ťažký“ nepochádza z pôvodnej publikácie škály.** Práca, ktorá 5-D zaviedla, uvádza len teoretický rozsah 5 až 25 a žiadne kategórie závažnosti nedefinuje. Použitý prah pochádza z neskoršej taiwanskej práce, ktorá kategórie odvodila lineárnou regresiou na číselnej škále u 409 dialyzovaných v jedinom centre – bez analýzy ROC a bez uvedenia senzitivity či špecificity. V tejto štúdii sa navyše skóre 11,5 zaokrúhľovalo nahor na 12, takže skutočný prah bol 11,5.
3. **Škála 5-D bola vyvinutá na meranie zmeny, nie na skríning.** Jej pôvodným určením bolo sledovať vývoj svrbenia v čase v klinických skúšaniach u pacientov, ktorí pruritus *majú* – prítomnosť svrbenia bola vstupným kritériom. Použitie ako prevalenčného skríningu v neselektovanej dialyzačnej populácii je mimo overeného účelu nástroja.
4. **Vylučovacie kritériá súbor systematicky očistili.** Vyradení boli pacienti s psychiatrickou diagnózou alebo klinicky zjavným psychiatrickým stavom, s aktívnym dermatologickým ochorením, s cholestázou, s malignitou, s akútnou infekciou a tí, ktorí v poslednom mesiaci začali novú systémovú antipruritickú liečbu. Vzniká tak „čistý“ obraz, ktorý sa vzďaľuje bežnej ambulancii – a vylúčenie psychiatrickej komorbidity pravdepodobne záťaž symptómom podhodnocuje, keďže depresia a úzkosť vnímanie aj hlásenie svrbenia priamo ovplyvňujú.
5. **Iné kohorty udávajú výrazne viac.** Francúzska prospektívna multicentrická štúdia so systematickým skríningom udáva stredne ťažký až ťažký pruritus u 23,5 %, novšie európske prehľady 31 až 40 %. Rozdiel autorky samy pripisujú odlišným nástrojom a prahom.

Praktický dôsledok: **prevalencia symptómu je funkciou toho, čím a s akou hranicou ho meriame.** Číslo 16,3 % platí pre túto škálu, tento prah a tento súbor. Prenášať ho na slovenskú dialyzačnú populáciu ako „každý šiesty“ by bolo nepresné v oboch smeroch.

Čo je na práci naozaj cenné

Ťažisko hodnoty nie je v prevalencii, ale v dvoch ďalších zisteniach.

Prvé: liečba, ktorú pacienti dostávajú, im väčšinou nepomáha. Nejaký liek na svrbenie pravidelne užívalo 212 z 294 pacientov (72,1 %), z toho perorálne antihistaminiká 143 (48,6 %) a krémy alebo emolienciá 96 (32,7 %). Účinok hodnotili takto:

Vnímaný účinok	Počet	Podiel z 212 užívateľov
Žiadny	100	47,2 %
Krátkodobý (≤ 24 h)	78	36,8 %
Dlhodobejší (> 24 h)	34	16,0 %

Takmer polovica liečených teda nemá zo svojej liečby žiadny úžitok. Údaj sa vzťahuje na akúkoľvek antipruritickú liečbu, nie osobitne na antihistaminiká. Tie sú len najčastejšie predpisovanou skupinou, hoci ich neúčinnosť pri uremickom prurite je patofyziologicky očakávaná, pretože svrbenie tu nie je sprostredkované histamínom.

Poznámka k údajom: pôvodná tabuľka uvádza tieto podiely vzťahované na celý súbor 294 pacientov (34,0 %, 26,5 % a 11,6 %). Vyššie uvedené podiely sú prepočítané na 212 skutočných užívateľov liekov, čo je klinicky zmysluplnejší menovateľ.

Druhé: pacienti symptóm nehlásia. Kvalitatívna fáza zahrnula všetkých 48 osôb so stredne ťažkým až ťažkým svrbením, každú aspoň v dvoch pološtruktúrovaných rozhovoroch. Vynorili sa štyri témy: bremeno pruritu (narušený spánok, emočná záťaž, stigma, kolísanie intenzity a jeho prijímanie ako nevyhnutnej súčasti liečby), zvládacie stratégie (chlad, emolienciá, lieky s útlmom), **bariéry v komunikácii** (váhanie ozvať sa, keď je personál zaneprázdnený, alebo keď má pacient pocit, že sa symptóm zľahčuje) a očakávania od starostlivosti (rozpor medzi očakávaným riešením a vnímaným dočasným efektom).

Práve táto časť vysvetľuje, prečo je pruritus v dokumentácii podhodnotený: nejde o to, že pacienti nesvrbia, ale že sa nepýtame a oni sami tému neotvoria.

Asociácie, ktoré sa nesmú prečítať naopak

Vo viacrozmernom modeli boli s vyšším rizikom stredne ťažkého až ťažkého svrbenia spojené komorbidné chronické ochorenie (pomer šancí 2,399; 95 % IS 1,126–5,112) a *predchádzajúca edukácia o prurite* (3,145; 1,258–7,859), s nižším rizikom manželský stav (0,418; 0,202–0,867). Pohlavie ani vek významné neboli.

- **Edukácia svrbenie nezhoršuje.** Ide o učebnicovú protopatickú zaujatosť: edukáciu dostali práve tí, ktorí mali ťažšie príznaky. Autorky to samy pripúšťajú a označujú to za reaktívne poskytovanie starostlivosti. Číslo nemožno interpretovať prognosticky ani kauzálne.
- **Manželstvo je zástupná premenná** pre psychosociálnu podporu, možno aj pre ochotu nahlásiť symptómy – nie je to ochranný faktor.
- **„Komorbidita“ je binárny súhrn** spájajúci diabetes, hypertenziu a srdcové ochorenie; nehovorí, ktorá z nich je relevantná.
- **Model je poddimenzovaný.** Na 48 udalostí pripadá šesť prediktorových stupňov voľnosti a odhad pre edukáciu stojí na deviatich udalostiach v 27-člennej exponovanej skupine, čomu zodpovedajú aj široké intervaly.
- **Chýba adjustácia na klinické determinanty.** V práci sa nevyskytuje Kt/V, fosfát, vápnik, parathormón, albumín, β2-mikroglobulín, hemoglobín ani xeróza – teda presne tie premenné, ktoré pri uremickom prurite zvažujeme ako prvé.

Vecná kontrola tvrdení

Tvrdenie	Verdikt	Presná interpretácia
Stredne ťažký až ťažký pruritus malo 16,3 % pacientov	Potvrdené	48 zo 294 pri prahu 5-D ≥ 11,5. Platí pre tento nástroj a prah, nie ako všeobecná prevalencia.
Svrbenie akéhokoľvek stupňa malo 34,4 %	Číslo potvrdené, formulácia nepresná	101 z 294 zodpovedá 5-D ≥ 9, teda **aspoň miernemu** svrbeniu podľa Laiových kategórií (9 – 11 mierne, 12 – 17 stredne ťažké). Nejde o „akýkoľvek stupeň“: škála má minimum 5 a pásmo 5 – 8 zodpovedá NRS = 0. Údaj je len v plnom texte, nie v abstrakte.
Zvyšných 65,6 % pacientov nesvrbí	Nesprávne	Kategória zodpovedá skóre 5–8 na škále s minimom 5; mierne alebo občasné svrbenie do nej spadá.
Prah ≥ 12 pochádza z pôvodnej publikácie škály 5-D	Nesprávne	Pôvodná práca kategórie závažnosti nedefinuje. Prah pochádza z neskoršej jednocentrickej taiwanskej práce (409 pacientov). Tá síce ROC analýzu urobila (plocha pod krivkou pre stredne ťažký pruritus podľa NRS ≥ 4 bola 0,915; 95 % IS 0,889 – 0,941), samotné deliace body však odvodila z rovnice lineárnej regresie, nie z ROC. Pri prahu 12 mala senzitivitu 75 % a špecificitu 89,3 %; autori sami žiadajú externú validáciu.

Tvrdenie	Verdikt	Presná interpretácia
Predchádzajúca edukácia je spojená s ťažším svrbením	Potvrdené, ale zavádzajúco	Ide o obrátenú príčinnosť: edukáciu dostali pacienti s horšími príznakmi. Autorky to samy uvádzajú.
Takmer polovica liečených nemá zo svojej liečby účinok	Potvrdené	100 z 212 užívateľov **akejkoľvek** antipruritickej liečby; údaj sa nevzťahuje osobitne na antihistaminiká. Tie sú len najčastejšie predpisovanou skupinou (143 z 294) a pri uremickom prurite nemajú patofyziologické opodstatnenie; štúdia však ich samostatnú účinnosť nehodnotila.
Štúdia hodnotí modernú liečbu (difelikefalín, gabapentinoidy, fototerapiu)	Nesprávne	Tieto možnosti sa v práci vôbec nevyskytujú. Nemožno ju citovať v terapeutickom kontexte.

Čo z toho vyplýva pre dialyzačnú ambulanciu

1. **Pýtať sa aktívne a pravidelne.** Bez cielenej otázky sa o symptóme nedozvieme – to je najlepšie doložené zistenie celej práce. Stačí jedna otázka pri mesačnej kontrole.
2. **Použiť jeden nástroj a držať sa ho.** Číselná škála 0 až 10 alebo 5-D sú obe použiteľné; dôležitejšie než výber je, aby sa u toho istého pacienta nemenila a aby sa hodnota zaznamenávala.
3. **Nezostať pri antihistaminikách.** Ich rozšírené podávanie je zvyk, nie dôkaz; polovica liečených z nich nemá úžitok a u starších pacientov prináša útlm a riziko pádov.
4. **Prejsť odstrániteľné príčiny.** Xerózu, dávku dialýzy, fosfátovo-kalciovú rovnováhu a parathormón, anémiu, liekovú anamnézu a kožné ochorenie, ktoré s obličkami nesúvisí.
5. **Vedieť, že existujú cielené možnosti.** Súčasné európske prehľady k liečbe pruritu pri dialýze uvádzajú aj gabapentinoidy, fototerapiu a agonisty κ-opioidných receptorov – tieto údaje však pochádzajú z inej literatúry než z opisovanej štúdie.
6. **Zmeniť prostredie rozhovoru.** Ak pacient váha ozvať sa, keď je personál zaneprázdnený, pomôže zaradiť otázku na svrbenie do pevnej štruktúry kontroly, nie ju ponechať na jeho iniciatívu.

Poznámka k spoľahlivosti zdroja

Práca je voľne dostupná a jej kvalitatívna časť je poctivo urobená, obsahuje však aj nezrovnalosti, ktoré redakčná kontrola nezachytila: vekové kategórie sú v dvoch tabuľkách obsadené navzájom opačne a časť podielov v tabuľke liečby má odlišné menovatele bez upozornenia. Z tohto dôvodu tento text nepreberá zo štúdie žiadne vekové údaje. Sekundárna spravodajská správa o štúdii navyše autorkám pripisuje tvrdenie o prenositeľnosti na severoamerickú populáciu, ktoré sa v pôvodnom článku nenachádza.

Záver

Zo štúdie si netreba odniesť číslo, ale mechanizmus. Prevalencia symptómu závisí od nástroja a prahu, takže rozdiel medzi 16 a 40 % je do veľkej miery sporom o meraní. Pripísať ho *výlučne* nástroju by však bolo predčasné: nijaká z týchto prác neporovnávala škály priamo v tej istej kohorte, takže skutočné rozdiely medzi populáciami (skladba pacientov, ročné obdobie, dialyzačná prax, komorbidity) sa vylúčiť nedajú. Klinicky použiteľné zistenie je iné a nemenej dôležité: **pacienti o svrbení nehovoria, dostávajú liečbu, ktorá im v polovici prípadov nepomáha, a s oboma vecami vieme niečo urobiť hneď.**

Súvisiace články

- Neuroimunitná architektúra uremického pruritu: model štyroch uzlov a jeho terapeutické dôsledky
- Kŕče kostrového svalstva pri dialýze: globálna prevalencia 55 % a čo s tým v praxi

- Stanovenie suchej váhy (EDW) pri hemodialýze: klinický odhad, BCM, BVM a POCUS

Spracovaný zdroj: *Turgay G, Özdemir Eler Ç. Chronic Kidney Disease-Associated Pruritus in Haemodialysis: A Mixed-Methods Study of Symptom Burden and Patient Experience. Journal of Renal Care. 2026;52(3):e70075. doi: 10.1111/jorc.70075. Plný text. PubMed.*

Pôvodná publikácia škály 5-D: *Elman S, Hynan LS, Gabriel V, Mayo MJ. The 5-D itch scale: a new measure of pruritus. British Journal of Dermatology. 2010;162(3):587–593. doi: 10.1111/j.1365-2133.2009.09586.x. PubMed.*

Zdroj použitých hraníc závažnosti: *Lai JW, Chen HC, Chou CY, Yen HR, Li TC, Sun MF, Chang HH, Huang CC, Tsai FJ, Tschen J, Chang CT. Transformation of 5-D itch scale and numerical rating scale in chronic hemodialysis patients. BMC Nephrology. 2017;18(1):56. doi: 10.1186/s12882-017-0475-z. PubMed.*

Porovnávacia prevalencia: *Lanot A, Bataille S, Rostoker G, Bataille P, Chauveau P, Touzot M, Misery L. Moderate-to-severe pruritus in untreated or non-responsive hemodialysis patients: results of the French prospective multicenter observational study Pruripreva. Clinical Kidney Journal. 2023;16(7):1102–1112. doi: 10.1093/ckj/sfad032. PubMed.*

Súčasný prehľad diagnostiky a liečby: *Latus J, Lanot A, Ständer S, Sanchez-Alvarez E, Aucella F, Yosipovitch G. CKD-associated pruritus in haemodialysis: a road map for diagnosis and treatment. Clinical Kidney Journal. 2025;18(5):sfaf096. doi: 10.1093/ckj/sfaf096. Plný text.*

Poznámka k dôkazovému základu: *Bibliografické údaje, autorstvo aj všetky číselné výsledky boli overené 23. augusta 2026 z otvoreného plného textu spracovanej práce, z PubMedu a z Crossrefu. Podiely vnímaného účinku liečby sú vlastným prepočtom na počet skutočných užívateľov liekov; pôvodná práca ich vzťahuje na celý súbor užívateľov. Vekové údaje sa z dôvodu vnútornej nezrovnalosti v pôvodných tabuľkách neuvádzajú.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=svrbenie-pruritus-na-dialyze-preco-sa-udavana-prevalencia-lisi-dvojnasobne-a-co-pacient-sam-nepovie · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.